Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Comarca de Campo Grande
4ª Vara do Juizado da Fazenda Pública e da Saúde Pública

TERMO DE CONCLUSÃO
Em / /2024, estes autos foram conclusos ao MM. Juiz de Direito da 4ª Vara do Juizado da Fazenda Pública e da Saúde Pública desta Comarca de Campo Grande - MS.

Escrivão/Analista

Autos n.º 0811068-59.2023.8.12.0110.
Autor(a): Alexandre Dalla Vechia Teixeira
Ré(u): Estado de Mato Grosso do Sul
Ação: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Vistos...

1. Alexandre Dalla Vechia Teixeira, representado por Pamela Dalla Vechia Teixeira, propôs a presente ação em desfavor do Estado de Mato Grosso do Sul, já qualificados, alegando, em síntese, que é portador de doença grave, sendo que, em virtude disso, foi a ele prescrito pelo médico que lhe assiste a utilização do medicamento indicado na exordial, aduzindo, outrossim, que é obrigação do ente federado demandado fornecê-la, de modo que, então, requereu à parte demandada o fornecimento da aludida medicação, não tendo, até o momento, sido atendido, o que reputa indevido. Diante de tais fatos, após fundamentar sua pretensão, pediu a concessão de tutela de urgência para o fim de compelir o réu a lhe disponibilizar a medicação mencionada e, definitivamente, a ratificação da tutela eventualmente deferida. Juntou documentos.

Após ter o Núcleo de Apoio Técnico do TJMS (NAT) emitido Parecer Técnico desfavorável, sendo que fora indeferida a tutela de urgência.

E em relação a essa última decisão, a parte Autora impetrou mandado de segurança, o qual teve a liminar indeferida

Na sequência, a parte demandada apresentou contestação onde em suma pugnou pela improcedência do pleito inicial.

Em impugnação, a parte autora rebateu os argumentos da contestação e repisou os termos da exordial, de modo que os autos, então, vieram conclusos para decisão.

É o breve relatório.
DECIDO.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIEL DELLA MEA RIBEIRO, liberado nos autos em 25/07/2024 às 19:02 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0811068-59.2023.8.12.0110 e código GVqAhh17.

Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Comarca de Campo Grande
4ª Vara do Juizado da Fazenda Pública e da Saúde Pública

2. Trata-se de ação ordinária na qual, ao que consta, pretende a parte autora que a parte demandada seja obrigada a fornecer à parte autora o(s) fármaco(s) prescrito(s) pelo médico que lhe atende - *"Aripiprazol 10mg".*

Inicialmente, à vista do relatado, da análise das provas documentais, bem como do teor das alegações das partes, tem-se que para o deslinde da questão se mostra desnecessária a produção de outras provas, pois o feito encontra-se apto para julgamento, nos moldes do art. 355, I, do NCPC, o que se passa a fazer.

> Na linha de precedentes do STJ, presentes as condições para o julgamento antecipado da lide (art. 330, CPC), é dever do magistrado, e não apenas uma faculdade, assim proceder
> TJMS - Apelação nº 0057253-84.2010.8.12.0001, 5ª Câmara Cível, Rel. Luiz Tadeu Barbosa Silva. unânime, DJ 22.01.2014.

No caso, é de se salientar desde logo que nos termos do art. 196 da CF/88 é dever do Estado prestar a devida assistência a saúde ao cidadão. Aliás, os princípios da dignidade da pessoa humana e da preservação da saúde dos cidadãos impõe, em sendo o caso, a União, Estado e ao Município, de modo *solidário* (art. 196, da CF), a obrigação de fornecer medicamentos, insumos e tratamentos médicos em favor de pessoas carentes, que comprovem a sua necessidade e pertinência por prescrição médica. Logo, tem-se que inclusive presente a legitimidade da parte demandada para figurar no pólo passivo da lide.

> REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO - ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - REMESSA E APELO NÃO PROVIDOS. Por força do que prescreve a Constituição da República, o SUS. Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. É dever do Município e do Estado providenciar tratamento de saúde gratuitamente para pessoas hipossuficientes, consoante se depreende da regra insculpida no artigo 196 da Constituição da República. Remessa e apelo não providos.
> TJMS - Apelação nº 0900075-24.2017.8.12.0029, 1ª Câmara Cível, Rel. João Maria Lós. j. 05.10.2018.
>
> AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - RESP. Nº 1.657.159 SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É solidária a responsabilidade dos entes públicos pela prestação de serviços de saúde, cabendo ao cidadão escolher em face de quem proporá a ação. A saúde é direito de todos e dever do Estado, o qual deverá garantir à sociedade a efetiva prestação de serviços mínimos para uma vida digna, não podendo valer-se da cláusula da reserva do possível para se abster de dar o efetivo cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana. (...)
> TJMS - Agravo Interno nº 0802932-18.2014.8.12.0004, 4ª Câmara Cível, Rel. Odemilson Roberto Castro Fassa. j. 12.09.2018.
>
> REMESSA OFICIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI. HMIB. DEVER DO ESTADO DE DISPONIBILIZAR VAGA. 1. Segundo o art. 196, da CF/88: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2. Independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal, é dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente. 3. Comprovada a necessidade de o autor internar-se imediatamente em Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Materno Infantil de Brasília, sob risco de morte, é dever do Estado de providenciar a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIEL DELLA MEA RIBEIRO, liberado nos autos em 25/07/2024 às 19:02 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0811068-59.2023.8.12.0110 e código GVqAhh17.

> vaga, a fim de garantir o bem estar e a saúde do paciente. 4. Remessa oficial não provida.
> TJDFT – 4ª Turma Cível. RMO nº 20150111022618, Rel. Arnoldo Camanho. j. 17.08.2016, DJe 29.08.2016.

E, quanto ao mérito, tem-se que a parte autora logrou demonstrar, em linha de princípio, ser portadora de uma moléstia, entretanto, no caso em debate observa-se que descabe acolhimento da pretensão posta na inicial não se observando de forma patente irregularidade do ente estatal, recusa ou omissão na disponibilização de medicamento(s) aptos ou pertinentes a tratar de sua enfermidade.

Assim, não se observa do colhido nos autos elementos que permitam concluir que ocorrera algum tipo de ilícito/irregularidade praticado pela parte ré, inclusive repisando que o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT/TJMS) se mostrou *desfavorável* ao pedido da parte autora quanto a solicitada medicação, e inclusive indica a existência de outros diversos medicamentos disponibilizados pela rede pública de saúde para tratamento da enfermidade apresentada pela parte autora , conforme conclusão de pp. 57/58, sendo tal elemento de cunho técnico e a ser observado pelo Juízo.

> AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REEXAME OBRIGATÓRIO - PACIENTE PORTADORA DE DEPRESSÃO - PEDIDO DE MEDICAMENTOS - PARECER DESFAVORÁVEL DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO - ENUNCIADOS DO CNJ - REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. Impende observar o parecer do Núcleo de Apoio Técnico - NAT (desfavorável), bem como, o entendimento recente contido nos Enunciados sobre Direito da Saúde da I Jornada realizada em São Paulo pelo Conselho Nacional de Justiça, no caso, notadamente os de números 11, 16 e 31, ao ser apreciado o pedido formulado na peça inicial. Remessa necessária provida.
> TJMS - Remessa Necessária nº 0803643-10.2016.8.12.0018, 5ª Câmara Cível, Rel. Vladimir Abreu da Silva. j. 11.07.2017.

Ademais, a decisão quanto a tutela antecipada às pp. 59/65 *indeferiu* o pedido de urgência, com base no parecer do NAT, sendo que não se denota que sobreveio aos autos *quaisquer* novos elementos a desmerecer tal conclusão do Núcleo de Apoio Técnico ou mesmo ao já decidido pelo Juízo quando do exame do pleito de tutela antecipada.

E, por seu turno e como se denota de pp. 57 foi apontado a existência de vários medicamentos atinentes ao tratamento da parte autora que são padronizados e disponibilizados pelo Ente Público, sem que houve efetiva prova que todos tenham sido previamente utilizados e que todos são ineficazes ao tratamento. E, sem tal prova como reiterada a jurisprudência do STJ (Tema 106) não cabe obrigar ao Estado a obrigação de ofertar medicamentos em *exclusividade* ao autor que não são padronizados.

> RECURSO NECESSÁRIO E APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELOS ENTES PÚBLICOS ESTADUAL E MUNICIPAL - MÉRITO - PARTE NÃO COMPROVA A IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO REQUERIDO, NEM QUE OS FORNECIDOS PELO SUS SÃO INEFICAZES PARA TRATAMENTO DE SUAS DOENÇAS - PRECEDENTE PARADIGMA DO STJ (TEMA 106) - REFORMA DA SENTENÇA - PEDIDO IMPROCEDENTE - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1) Em não sendo comprovada a indispensabilidade do medicamento pleiteado, nem que os fármacos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da moléstia do paciente já foram utilizados ou são ineficazes, não há se falar em obrigação da rede pública de saúde no fornecimento de medicamento diferenciado, não listado na relação de medicamentos do SUS. Precedente paradigma estabelecido pelo STJ, no julgamento do RESp nº 1.657.156/RJ (Tema 106). 2) Recursos Necessário e Voluntário conhecidos e providos.
> TJMS - Apelação nº 0803547-58.2017.8.12.0018, 2ª Câmara Cível do TJMS, Rel. Nélio Stábile. J. 20.08.2019.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIEL DELLA MEA RIBEIRO, liberado nos autos em 25/07/2024 às 19:02 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0811068-59.2023.8.12.0110 e código GVqAhh17.

Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Comarca de Campo Grande
4ª Vara do Juizado da Fazenda Pública e da Saúde Pública

Nesta toada, cabe observar os documentos de p. 29 com os disponibilizados pelo Poder Público às pp. 57 para se vislumbrar que não consta que todos os padronizados foram utilizados e nem há prova concreta que são ineficazes.

7. Esclarecer se a(s) alternativa(s) terapêutica(s) do SUS para a(s) moléstia(s) a seguir indicada(s) já foi(ram) utilizada(s):
( )Olanzapina ( )Quetiapina (✓)Risperidona ( )Ziprasidona ( )Clozapina ( )Aloperidol – antipsicóticos
( )Carbonato de Lítio – estabilizador de humor
( )Valproato de sódio ou ácido valpróico ( )Fenitoína ( )Fenobarbital ( )Carbamazepina – anticonvulsivantes
( )Cloridrato de amitriptilina ( )Cloridrato de clomipramina ( )cloridrato de nortriptilina – antidepressivos
( )Fluoxetina – inibidor de receptação de serotonina
( )Clonazepam ( )Diazepam – ansiolíticos

NAT:

Considerando que Aripiprazol não está padronizado na RENAME 2022.

Considerando o PCDT do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo, Portaria Conjunta SAES/SCTIE/MS n° 07 de 12/04/2022, que oferece o medicamento Risperidona, sendo que o paciente não está cadastrado.

Considerando o PCDT do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade – TDAH, Portaria Conjunta SAS/MS nº 14 de 29/07/2022, que não preconiza o uso de medicamentos, sendo que o paciente não está cadastrado.

Considerando a Política Nacional de Saúde Mental.

Considerando as evidências científicas disponíveis, tratamentos realizados.

Considerando que o registro de aripiprazol na ANVISA não inclui indicação para o tratamento de autismo, ou uso pediátrico, portanto, trata-se de uma indicação *off label*.

Considerando que a RENAME 2022 tem padronizado no CBAF medicamentos antipsicóticos (Clorpromazina, Decanoato de Haloperidol, Haloperidol), antidepressivo (Amitriptilina, Clomipramina, Nortriptilina, Fluoxetina), anticonvulsivantes (Carbamazepina, Fenitoína, Fenobarbital, Valproato de Sódio), ansiolíticos (Clonazepam, Diazepam), estabilizador do humor (Carbonato de Lítio).

E, de outra banda, importante consignar que não há indicativo documental colacionado de recusa de fornecimento de outros medicamentos/tratamento pelo poder público via SUS a atender a enfermidade/moléstia que possuiria a parte autora.

Outrossim, mostra relevante também deixar consignado que como consta no parecer emitido pelo NAT (p. 57) que o medicamento objeto deste feito trata-se de uma indicação *off label* e não inclui indicação, junto a ANVISA, para tratamento da enfermidade que acomete o autor.

E, consoante tese fixada pelo STJ no julgamento do PUIL 2.101-MG (julgado em 10/11/2021), *"O Estado não é obrigado a fornecer medicamento para utilização off label, salvo autorização da ANVISA"*.

Ademais, repise-se que o medicamento/tratamento solicitado não é padronizado no SUS/Rename e como visto a União nem se encontra no polo passivo da lide, o que seria pertinente, haja vista que é prerrogativa do Ministério da Saúde - órgão vinculado ao ente federal -, ouvida a CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS), incorporar,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIEL DELLA MEA RIBEIRO, liberado nos autos em 25/07/2024 às 19:02 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0811068-59.2023.8.12.0110 e código GVqAhh17.

Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Comarca de Campo Grande
4ª Vara do Juizado da Fazenda Pública e da Saúde Pública

excluir, ou alterar novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. Aliás, é que o dessume do art. 19-Q, da Lei 8.080/90:

> "Art. 19-Q. A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS".

E, por sua vez, anote-se que o Enunciado nº 78 das Jornadas de Direito de Saúde do CNJ já aponta para que *"Compete à Justiça Federal julgar as demandas em que são postuladas novas tecnologias ainda não incorporadas ao Sistema Único de Saúde – SUS".*

Aliás, é nítida a imprescindibilidade da União Federal em figurar no polo passivo da lide, sendo que tal questão, inclusive, fora objeto de discussão no âmbito do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF, que por meio da Tese fixada no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 855.178, em Repercussão Geral, verberou "(...) v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação" (Tema nº 793 do STF). E, tal fora o que restou assentado no dispositivo do voto Min. Edson Fachin, Redator do Acórdão.

> AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO DETERMINADO PELO JUÍZO ESTADUAL ATÉ O REEXAME DA MATÉRIA PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA COMPETENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
> STF – 1ª Turma. RE 1389742 AgR. Re. Min. CARMEN LÚCIA. Julg. 22.08.2022.
>
> Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à saúde. Responsabilidade solidária. 4. Fornecimento de medicamento não incluído nas políticas públicas. A União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. Aplicação correta do tema 793. Precedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.
> STF – 2ª Turma. Rel. Min. GILMAR MENDES. Reclamação 48760 AGR. Julg. 04.10.2021. Publ. 11.10.2021.

Entretanto, tem-se que a parte autora preferiu não litigar contra aquele que possui as condições e competência para incluir ou não o objeto/tratamento pugnado na esfera do SUS, sendo que em observância inicial de pertinência ou adequação de discussão da questão apenas contra o Réu nominado na inicial, e em não sendo o objeto dos autos padronizado na Rename e/ou SUS (conforme consta do parecer do NAT já juntado aos autos), não se mostra a princípio demonstrado de plano a obrigação da parte Estatal ora demandada na sua compra, entrega ou disponibilização à parte autora de pretensão de objeto não padronizado no SUS ou não constante da Rename.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIEL DELLA MEA RIBEIRO, liberado nos autos em 25/07/2024 às 19:02 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0811068-59.2023.8.12.0110 e código GVqAhh17.

Assim, e se há mora na análise de medicamento não padronizado tal não é de alçada de Ente Estadual ou Municipal, mas da União. E, ao que consta não cabe ao Ente Estadual ou Municipal fazer tal incorporação/padronização no Sistema de Saúde Pública – inclusive a dar azo a posteriores compras/licitações e consequente disponibilização de produtos - , descabendo a obrigação legal do gasto de valores públicos em aquisição de medicamento/tratamento que nem fora avaliado e muito menos acolhido pelo Poder Público e pelos órgãos de saúde competentes e a indicar a pertinência e benefícios do objeto e a dar azo a destinação do limitado erário público em tal aquisição.

Logo, anote-se por oportuno que, ao que consta, se a medicação pugnada nem mesmo fora avaliada e aprovada por órgãos de saúde competentes a avaliar pertinência, adequação, efeitos e benefícios a ser padronizada não se pode querer, de plano, que ente público que não tem condição e nem competência para isso, por conta, passe a adquirir e ser obrigada a adquirir produtos/objetos/tratamento que nem mesmo foram avaliados e quiçá aprovados para figurarem naqueles que estão aptos e indicados para compra e distribuição pelo Poder Público, e desta feita, indicados para gastos de valores públicos.

Logo, em não estando a União figurando no polo passivo da lide, bem como não se observando desta feita de plano e de forma patente a obrigação de ente Estadual e/ou Municipal diante da não padronização do objeto dos autos de disponibilizar produto/procedimento/medicamento a prévia análise e incorporação pelo Ministério da Saúde não se verifica probabilidade do direito contra a parte ora demandada, segundo a inicial como posta e sem a possibilidade de participação da União na lide.

Aliás, como dito, não se vislumbra de plano irregularidade na ausência de disponibilização por ente Estadual/Municipal de produtos não analisados, aprovados e incorporados no SUS, Rename e padronizados, sendo de responsabilidade da União tal análise. E, como já asseverou o Min. Rel. ROBERTO BARROSO em trecho da ementa da Reclamação nº 45.777-MC (DJe 11.03.2021) "Não faz sentido, no quadro de penúria dos Estados, que caiba a eles providenciar tratamento de responsabilidade da União, para só depois pedirem ressarcimento".

Logo, cabe, então o caminho da improcedência da pretensão deduzida na inicial.

> APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MÉRITO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PARECER DESFAVORÁVEL DO NAT - EXISTÊNCIA DE TRATAMENTO OFERECIDO PELO SUS - RECURSO DESPROVIDO. Não havendo provas de que a parte tenha se submetido ao tratamento disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde ou que são ineficazes ou que tenha feito uso desses fármacos e que tenha havido rejeição, deverá, primeiro fazer uso dos medicamentos fornecidos pela rede pública.
> TJMS - Apelação nº 0800661-85.2015.8.12.0041, 3ª Câmara Cível, Rel. Eduardo Machado Rocha. j. 08.10.2018.
>
> RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. ARTIGO 196, DA CF/88. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS E INSUMOS. PACIENTE PORTADOR DE TETRAPLEGIA ESPÁSTICA. MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO DOS INSUMOS E DOS MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS E QUE TIVERAM NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DEMONSTRADA. REFORMA DA SENTENÇA NO QUE CONCERNE AO DEFERIMENTO DOS MEDICAMENTOS LYRICA, SEROQUEL XRO, AMBROXOL E LUFTAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA MÉDICA PARA O FORNECIMENTO DE TAIS FÁRMACOS QUE NÃO SÃO INDICADOS PARA O QUADRO CLÍNICO DO RECLAMANTE. PARECER DO NAT/JUD DESFAVORÁVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIEL DELLA MEA RIBEIRO, liberado nos autos em 25/07/2024 às 19:02 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0811068-59.2023.8.12.0110 e código GVqAhh17.

Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Comarca de Campo Grande
4ª Vara do Juizado da Fazenda Pública e da Saúde Pública

FORNECIMENTO DO SUPLEMENTO RARIVIT, POIS HÁ ALTERNATIVA FORNECIDA PELO SUS (POLIVITAMINICO), A QUAL, INCLUSIVE, FOI PLEITEADA PELO AUTOR NESTA DEMANDA. REFORMA DA SENTENÇA PARA INDEFERIR O PLEITO DE RECEBIMENTO DO MEDICAMENTO MINILAX. RECLAMANTE QUE NÃO COMPROVOU A NECESSIDADE DO MEDICAMENTO, NEM A INEFICÁCIA DO FÁRMACO ALTERNATIVO CONTIDO NA LISTA DO SUS. NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO REQUERIDO PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA QUE ACOMETE O AUTOR E TAMPOUCO A INEFICÁCIA DA ALTERNATIVA TERAPÊUTICA OFERECIDA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. OBRIGATORIEDADE DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO USO DOS MEDICAMENTOS DEFERIDOS A CADA (6) MESES. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
Turma Recursal do Estado de Sergipe/TJSE, Recurso Inominado nº 201701009799, Rel. Isabela Sampaio Alves. j. 15.08.2018.

3. ISSO POSTO, nos termos do art. 487, I do NCPC, JULGA-SE IMPROCEDENTE a pretensão deduzida por Alexandre Dalla Vechia Teixeira, representado por Pamela Dalla Vechia dos Santos, em desfavor do Estado de Mato Grosso do Sul, já qualificados, extinguindo-se o feito com resolução de mérito.

No mais, comunique-se ao Relator do procedimento de p. 87 quanto ao julgamento do feito, caso ainda em trâmite – sendo que em consulta ao SAJ a princípio não houve alteração do decidido em sede de tutela nestes autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao MP. Sem custas.

Oportunamente, dê-se baixa e arquivo do feito.

Diligências legais.
Campo Grande, 24 de julho de 2024.

Daniel Della Mea Ribeiro
Juiz de Direito
(assinado por certificação digital)

RECEBIMENTO
Em / /2024, foram-me entregues estes autos em cartório._____Escrivão/Analista

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIEL DELLA MEA RIBEIRO, liberado nos autos em 25/07/2024 às 19:02 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0811068-59.2023.8.12.0110 e código GVqAhh17.